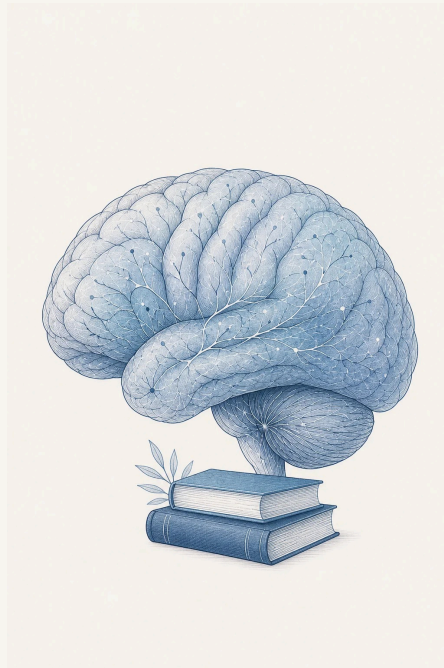


AMOSTRA GRATUITA · TRECHO DO GUIA

ROTEIRO PSIQUIÁTRICO

*Leia o Capítulo 1 — os princípios da entrevista,
com as dicas de como conduzir a escuta e
organizar o raciocínio.*



Julia Assucena Medrado de Castro

MÉDICA · CRM-SP 285002 · residente em Psiquiatria

Revisão técnica: Marina Araújo Silveira — MÉDICA · CRM-BA 41016 ·
CRM-SP 285066

1

Princípios da entrevista psiquiátrica

Antes de apresentar os roteiros específicos para cada transtorno, é fundamental abordar sete princípios técnicos que orientam e permeiam todos os capítulos deste livro.

O funil: do aberto ao fechado.

Toda investigação começa com pergunta aberta ("como tem estado o seu ânimo?"), evoluindo para perguntas dirigidas de esclarecimento ("isso acontece todo dia?") e, somente então, consolidando-se em critérios diagnósticos específicos ("nas últimas duas semanas, isso ocorreu na maior parte dos dias?"). Inverter o funil — abrir a consulta com checklist — produz respostas pobres e paciente passivo.

Âncoras de tempo e de fato.

Memória de sintoma é imprecisa. Ancore períodos em marcos da vida do paciente ("isso já era assim no Natal? antes ou depois de você perder o emprego?") e prefira fatos contáveis a rótulos ("quantas noites por semana", e não "você tem insônia?").

Normalizar antes de perguntar o difícil.

Tópicos que costumam despertar vergonha ou desconforto — como ideação suicida, comportamentos violentos, sexualidade, comportamentos purgativos e uso de substâncias psicoativas — são mais bem explorados quando precedidos por uma frase que normaliza a experiência, apresentando-a como algo comum e

humano. Exemplo de abordagem: "Muitas pessoas que passam por situações semelhantes às suas relatam pensamentos de desistir da vida. Isso já aconteceu com o senhor/a senhora?"

Perguntar por comportamento, não por diagnóstico.

"Você tem compulsão?" rende menos que "o que acontece quando você abre um pacote de bolacha?". O paciente é especialista na própria vida, não na nossa nomenclatura.

A resposta vaga é um dado.

"Vou levando", "normal", "mais ou menos" pedem concretização: peça o filme de ontem, da hora de acordar à hora de dormir. Um dia descrito em detalhe vale mais que dez adjetivos.

O acompanhante é instrumento diagnóstico.

O acompanhante pode mudar completamente o diagnóstico em casos de mania, demência, psicose e TDAH. Por isso, é importante ouvir o que ele tem a dizer. No entanto, em toda avaliação é preciso reservar um momento a sós com o paciente. É nesse espaço que costumam aparecer informações que o paciente não revela na frente de outras pessoas, como violência doméstica, uso de substâncias e ideação suicida.

Anote as frases, não só os sintomas.

A transcrição literal das falas do paciente (ex.: "sinto um aperto que não desgruda") no prontuário médico é uma prática fundamental para a preservação da riqueza psicopatológica. A conversão imediata e exclusiva para o jargão técnico pode descaracterizar nuances importantes da experiência subjetiva do indivíduo. Além disso, o registro fiel das palavras do paciente constitui um importante respaldo jurídico-legal para o examinador, especialmente em avaliações de risco, ao documentar objetivamente o estado do paciente no momento do atendimento.

PÉROLA CLÍNICA

A aliança vem antes do dado: paciente que se sente interrogado esconde; paciente que se sente compreendido conta. Se a entrevista travar, largue o roteiro e devolva o que ouviu: "deixa eu ver se entendi o que você está vivendo...". O roteiro serve à conversa, nunca o contrário.

VOCÊ LEU O CAPÍTULO 1

Este é só o começo do roteiro.

O guia completo traz o mesmo método aplicado **transtorno a transtorno**: depressão, bipolar, risco de suicídio, ansiedade, TOC, TEPT, álcool e substâncias, psicose, delirium, demência, transtornos alimentares, TDAH no adulto, sintomas somáticos e transtornos da personalidade.

- **16 capítulos + 3 apêndices práticos**
- **Exame do Estado Mental**, checklists de consulta rápida e exemplos de registro clínico
- Caixas *Pérola clínica*, *Atenção* e *Como falar* ao longo do guia
- **94 páginas**, em PDF pesquisável

Adquira o guia completo pelo link na bio das autoras.

Roteiro Psiquiátrico · guia prático de anamnese e exame do estado mental. Material educacional destinado a médicos, médicos residentes e estudantes de Medicina. Não substitui julgamento clínico individualizado, protocolos institucionais nem avaliação presencial. Voltado à avaliação de adultos. Em situações de crise ou risco de suicídio, procure atendimento imediato — CVV 188 ou SAMU 192.

Autoria: Julia Assucena Medrado de Castro — MÉDICA — CRM-SP 285002

Revisão técnica: Marina Araújo Silveira — MÉDICA — CRM-BA 41016 · CRM-SP 285066 — Medicina de Família e Comunidade RQE 27384 (BA)

© 2026. Trecho do livro “Roteiro Psiquiátrico” (1ª ed., 2026). Todos os direitos reservados.